

**Nr. 353 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes gegen Mißstände im Gesundheitswesen. [28. Mai 1934]<sup>1)</sup>***R 43 II/720, Bl. 14 und 20–25 Umdruck**Beginn:**Beginn:*

Seit einigen Jahrzehnten hat in fast allen Schichten des Volkes ein überaus starker Geburtenrückgang um sich gegriffen. Die Geburtenziffer ist von 2 032 000 im Jahre 1901 nach und nach auf 1 032 000 im Jahre 1931 und auf 978 000 im Jahre 1932 abgesunken. Im Jahre 1933 hat sie weiter bis auf 956 915 Geburten abgenommen. Diese bedauerliche Erscheinung beruht zum großen Teil auf der Ausbreitung einer Gesinnung und Denkungsweise, der äußeres Wohllleben mehr gilt als ideelle Güter, der die Sorge um die eigene Bequemlichkeit höher steht als die Sorge um die Zukunft von Volk und Vaterland. Die in der Nachkriegszeit wachsende Ausbreitung dieser Gesinnung ist eine Auswirkung des früheren Regierungssystems, das mit seiner materialistischen Auffassung vom Sinn des Lebens das gesunde Empfinden des deutschen Volkes verwirrt und zu den ihm innerlich fremden Gedankengängen marxistischen Geistes hinabgeführt hat. Die Regierung der nationalen Erhebung sieht es als eine ihrer vornehmsten Aufgaben an, hierin Wandel zu schaffen. Die Heranbildung einer Staatsgesinnung, die zu jedem Opfer für die Zukunft von Volk und Reich bereit ist, erfordert eine volkserzieherische Arbeit auf lange Sicht, die von der nationalsozialistischen Regierung seit dem ersten Tage der Machtübernahme in Angriff genommen worden ist und ihre Tätigkeit auf den verschiedensten Gebieten des öffentlichen Lebens noch lange in Anspruch nehmen wird. Der vorliegende Gesetzentwurf will nur auf einem Teilgebiet durch Abstellung grober Mißstände im Gesundheitswesen zur Lösung der Hauptaufgaben beitragen.

Die Vertreter der liberalistischen und marxistischen Weltanschauung haben es stets verstanden, ihre Irrlehren dem Volk dadurch als eine höhere Weisheit verlockend hinzustellen, daß sie sie mit gelehrte klingenden Schlagworten verbrämen. So wurde die Lehre vom „Ein- oder Zweikindersystem“ mit den Schlagworten „Geburtenregelung“ und „Rationalisierung der Geburten“ begründet. Was der eigenen Bequemlichkeit entsprang, erhielt hiermit eine Rechtfertigung, vor welcher das gesunde Empfinden, die Freude am Kinde, als intellektuell rückständig erschien. So war der Boden vorbereitet für Geschäftemacher, die durch geschickte Werbung unter Verwendung derselben Schlagworte im Volke die Kenntnis der Mittel zur Verhütung der Empfängnis und Unterbrechung der Schwangerschaft verbreiteten und ihre Waren in großen Mengen auf den Markt brachten. Zugleich wurde mit Erfolg auf eine Lockerung der Auffassung über die Zulässigkeit der Schwangerschaftsunterbrechung hingearbeitet, indem man dafür Stimmung machte, daß insbesondere auch soziale und wirtschaftliche Gründe eine Unterbrechung der Schwangerschaft zu rechtfertigen vermöchten („soziale Indikation“). Der ungeheuere Geburtenrückgang der Nachkriegszeit, der das natürliche Wachstum des Volkes zum Stillstand gebracht hat, ist wesentlich auf dieses Treiben zurückzuführen, das von dem vergangenen Regierungssystem teilweise geduldet, jedenfalls aber nicht scharf genug bekämpft worden ist.

Der Entwurf tritt diesen Mißständen entgegen.

Im einzelnen ist folgendes zu bemerken:

<sup>1)</sup> Unter diesem Datum vom RIM mit dem Gesetzentwurf an den StSRkei als Kabinettsvorlage übersandt. Der Gesetzentwurf wurde in der Kabinettsitzung am 3. 7. 34 beraten, jedoch nicht verabschiedet. S. dazu Dok. Nr. 376, P. 4, dort auch Anm. 10.

## Zum I. Abschnitt

Während es ursprünglich ein feststehender, von der gesamten Ärzteschaft anerkannter Grundsatz war, daß ein Arzt eine Schwangerschaft nur beim Vorliegen unmittelbarer, durch kein anderes Mittel zu beseitigender Lebensgefahr der Schwangeren unterbrechen dürfe, hat sich inzwischen unter dem Einfluß der oben dargelegten volksschädlichen Auffassungen bei einem Teil der Ärzteschaft das Bewußtsein der Pflicht abgeschwächt, alle nicht durch besondere gesundheitliche Rücksichten gebotenen Eingriffe zu unterlassen, welche die Geburt einer lebensfähigen Frucht verhindern sollen. Es ist daher dringend geboten, den Mißstand der leichtfertigen, die Gesundheit der Frau gefährdenden Schwangerschaftsunterbrechung abzustellen. Zugleich muß der unzulässigen Beseitigung der Gebärfähigkeit entgegengetreten werden. Da ferner der Verpflichtung der gesunden Frau, Kinder zu gebären und sich der Möglichkeit dazu nicht ohne ausreichenden Grund berauben zu lassen, die Pflicht des Mannes entspricht, sich zeugungsfähig zu erhalten, muß auch die künstliche Beseitigung der Zeugungsfähigkeit unterbunden werden. Eine Ausbreitung der bisher wohl noch seltenen Fälle der künstlichen Unfruchtbarmachung des Mannes wäre immerhin zu befürchten, sobald einer leichtfertigen Beseitigung der Gebärfähigkeit der Frau Einhalt getan ist.

Zu § 1: Im § 1 Abs. 1<sup>2)</sup> wird in Erfüllung vielfacher Wünsche aus Ärztekreisen klargestellt, unter welchen Voraussetzungen eine Schwangerschaft unterbrochen, die Zeugungs- oder Gebärfähigkeit beseitigt werden darf; der Arzt soll nur dann zu diesen Eingriffen berechtigt sein, wenn er nach gewissenhafter Prüfung die pflichtgemäße Überzeugung gewonnen hat, es sei der Eintritt des Todes der behandelten Person zu befürchten oder ihre Gesundheit ernstlich gefährdet, falls die Unfruchtbarmachung nicht vorgenommen wird oder das Kind im Mutterleibe zur normalen Austragung gelangt. Damit wird eindeutig die alleinige Zulässigkeit der aus gesundheitlicher (medizinischer) Indikation gebotenen Unfruchtbarmachung oder Schwangerschaftsunterbrechung gesetzlich festgelegt. Die aus einem anderen Grunde vorgenommene Schwangerschaftsunterbrechung würde als Abtreibung strafrechtlich zu ahnden sein. Die hier vorgeschlagene Bestimmung über die Zulässigkeit der Schwangerschaftsunterbrechung stimmt mit der bei der Reform des Strafrechts in Aussicht genommenen Art der Regelung überein (zu vgl. § 254 des Entwurfs eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs<sup>3)</sup>).

Wegen des Erfordernisses der „Einwilligung des Betroffenen“ bleibt für die Fälle der beschränkten Geschäftsfähigkeit und der Geschäftsunfähigkeit Näheres über die Beteiligung des gesetzlichen Vertreters den auf Grund von § 19 des Entwurfes zu erlassenden Ausführungsvorschriften vorbehalten.

Bei Entscheidung der Frage, wer unter der angegebenen Voraussetzung befugt sein soll, Eingriffe der bezeichneten Art vorzunehmen, war zu berücksichtigen, daß nach geltendem Recht die Ausübung der Heilkunde jedermann ohne Rücksicht auf ärztliche Vorbildung offen steht. Wenn im Entwurf Nichtärzte ausgeschlossen werden, so hat das seinen Grund darin, daß bei einem so folgenschweren Eingriff ein besonderes Maß von Sachkunde und Erfahrung erforderlich ist, um die Voraussetzungen, unter denen er künftig noch zulässig sein soll, richtig abzuwägen und ihn nach allen Regeln der ärztlichen Kunst mit dem Erfolge der Erhaltung des Lebens und der Gesundheit durchzuführen.

2) § 1 Abs. 1 des Entwurfs: „Eine Unterbrechung der Schwangerschaft sowie eine Unfruchtbarmachung (Sterilisation), soweit diese nicht nach den Vorschriften des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 (RGBl. I, S. 529 [vgl. auch Dok. Nr. 193, P. 7]) erfolgt, darf nur durch einen approbierten Arzt mit Einwilligung des Betroffenen und nur dann vorgenommen werden, wenn es nach den Regeln der ärztlichen Kunst zur Abwendung einer auf andere Weise nicht abwendbaren ersten Gefahr für das Leben oder die Gesundheit des Betroffenen erforderlich ist.“

3) § 254 des vom RJM am 14. 5. 27 dem RT vorgelegten „Entwurfs eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches“ (RT-Drucks. Nr. 3390, Bd. 415): „Eine Abtreibung im Sinne dieses Gesetzes liegt nicht vor, wenn ein approbierter Arzt eine Schwangerschaft unterbricht, weil es nach den Regeln der ärztlichen Kunst zur Abwendung einer auf andere Weise nicht abwendbaren ersten Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der Mutter erforderlich ist. – Eine Tötung im Sinne dieses Gesetzes liegt nicht vor, wenn ein approbierter Arzt aus dem gleichen Grunde ein in der Geburt begriffenes Kind tötet.“

Durch Satz 1 des Abs. 2 wird klargestellt, daß auch eine Beseitigung der Keimdrüsen (Kastration) nur unter den für die Vornahme der Unfruchtbarmachung und der Schwangerschaftsunterbrechung gedachten Voraussetzungen vorgenommen werden darf.

Im Satz 2 des Abs. 2 wird von dem Grundsatz der Ausschließlichkeit des medizinisch indizierten Eingriffs abgewichen, indem fürderhin die Kastration auch zulässig sein soll, um einen mit entarteter geschlechtlicher Veranlagung behafteten Menschen davor zu bewahren, abermals dem Trieb, sich sittlich zu vergehen, zu erliegen und sich erneut straffällig zu machen. Nachdem nunmehr durch die Vorschrift des § 42 k des Strafgesetzbuchs in der Fassung des Gesetzes vom 24. November 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 995) die zwangsweise Entmannung gefährlicher Sittlichkeitsverbrecher vorgesehen ist<sup>4)</sup>, lag der Gedanke, die freiwillige Entmannung in dem im Entwurf gekennzeichneten Umfang zuzulassen, umso näher, als damit ernste Gefahren für Mitglieder der Volksgemeinschaft, nämlich für diejenigen, welche das Opfer etwaiger künftiger Sittlichkeitsverfehlungen sein würden, abgewendet werden. Die vorgesehene amts- oder gerichtsärztliche Begutachtung erscheint zur Abwehr von Mißbräuchen geeignet und ausreichend.

Der Abs. 3<sup>5)</sup> dient einer jeden Zweifel ausschließenden Klarstellung.

Zu § 2: Hinsichtlich der Beseitigung der Zeugungs- oder Gebärfähigkeit, sei es durch Sterilisation oder durch Kastration (Unfruchtbarmachung im weitesten Sinne), war das Gutachterverfahren (§§ 3–5) nur für die Fälle ins Auge zu fassen, in denen der Eingriff unmittelbar aus gesundheitlichen Gründen begehrt wird, um z. B. bei einer Frau weitere Schwangerschaften zu verhindern, die ihren Gesundheitszustand ernstlich gefährden könnten. Für die Fälle, in denen eine – an sich nicht bezweckte – Unfruchtbarmachung zwangsläufig dadurch bewirkt wird, daß erkrankte Teile der Geschlechtsorgane entfernt werden müssen, ist aus dringenden praktischen Erwägungen von dem Erfordernis der Begutachtung abgesehen worden. Hierzu sei nur bemerkt, daß gerade bei Frauen vor Öffnung der Leibeshöhle vielfach überhaupt nicht beurteilt werden kann, ob die Operation eine Unfruchtbarmachung zur Folge haben wird.

Bei der Vorschrift im Abs. 2 des § 2<sup>6)</sup> ist insbesondere an Fälle gedacht, in denen der Patient infolge Bewußtlosigkeit zur Erklärung seiner Einwilligung außerstande ist, der Arzt aber nach dem getroffenen Befund sich unmittelbar vor die Notwendigkeit eines pflichtgemäßen schnellen Handelns gestellt sieht.

Zu §§ 3–5: Die §§ 3–5 regeln das Gutachterverfahren, das der Vornahme der Schwangerschaftsunterbrechung und der Beseitigung der Zeugungs- oder Gebärfähigkeit voranzugehen hat. Hierzu sei erinnert an frühere Anregungen maßgeblicher ärztlicher Körperschaften, wonach solche Eingriffe nur auf Grund einer Beratung mehrerer Ärzte zulässig sein sollten. Die im Entwurf vorgesehene Begutachtung geht noch darüber hinaus, indem das Verfahren sich unter Ausschluß des behandelnden Arztes vollziehen soll. Der Entwurf nimmt auf Fälle gebührend Rücksicht, in denen die Lebensgefahr für die behandelte Person so groß und die Schwierigkeit der Herbeiführung der gutachtlichen Entscheidung so erheblich ist, daß ein längeres Zuwarten zu schlimmen Folgen führen könnte.

Das Gutachterverfahren wird nach dem Vorschlage des Entwurfs gänzlich in die Hände der Deutschen Ärzteschaft gelegt. Dies erscheint durch die Natur der Sache gerechtfertigt. Denn die Prüfung der nachträglich meist nur sehr schwer feststellbaren gesundheitlichen Notwendigkeit eines solchen Eingriffs ist eine Berufs- und Standesangelegenheit von größter Bedeutung. Die Beseitigung vorhandener Mißstände wird überdies durch eine planmäßige Erziehungsarbeit der Standes-

4) Vgl. Dok. Nr. 244, P. 10, dort auch Anm. 22.

5) § 1 Abs. 3 des Entwurfs: „Der Unterbrechung der Schwangerschaft steht im Sinne dieses Gesetzes die Tötung eines in der Geburt begriffenen Kindes gleich.“

6) § 2 Abs. 2: „Fehlt die zur Unterbrechung der Schwangerschaft oder zur Unfruchtbarmachung oder zur Entfernung der Keimdrüsen erforderliche Einwilligung, so ist der Eingriff gleichwohl statthaft, sofern die Einwilligung nicht abgewartet werden kann, ohne daß das Leben oder die Gesundheit des Betroffenen gefährdet wird.“

organisation besser verbürgt als durch bloße Strafandrohung. Durch die nahe bevorstehende Errichtung einer umfassenden ärztlichen berufsständischen Körperschaft (Reichsärztekammer) wird die organisatorische Voraussetzung für die Erfüllung der so wichtigen Aufgabe geschaffen werden.

Die Tätigkeit des Gutachters ist in dem Entwurf als eine ehrenamtliche gedacht. Für die Ärzte soll es eine besondere Ehrenpflicht sein, bei der gegenseitigen Überwachung auf dem in Rede stehenden Gebiet ärztlicher Tätigkeit mitzuarbeiten. Die besondere Vertrauensstellung des Gutachters macht den Ausschluß nichtärztlicher Ärzte vom Gutachteramt erforderlich.

Dem Leiter der Gutachterstelle ist für den Regelfall nur eine das Verfahren ordnende und überwachende Stellung ohne materielle Entscheidungsbefugnis zugedacht. Lediglich für den Fall, daß Gefahr im Verzuge ist, soll er nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen entscheiden können.

Im übrigen ist in der Verfahrensregelung darauf Bedacht genommen, daß die Gutachter möglichst unabhängig und unbeeinflußt von materiellen Interessen ihre Tätigkeit ausüben.

Zu § 6: Die Bestimmung, daß der Eingriff nur in einer Krankenanstalt vorgenommen werden darf, dient der Sorge um die zuverlässige Ausführung des Eingriffs. Auf die gleiche Regelung in § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses darf hingewiesen werden.

Zu § 7: Bei der Regelung der Kostenfrage in Abs. 1 des § 7 wird klargestellt, daß die Kosten des Gutachterverfahrens tragen soll, wer die Kosten des ärztlichen Eingriffs aufzubringen hat<sup>7)</sup>). Für die Fälle der Hilfsbedürftigkeit im Sinne der Fürsorgepflichtverordnung<sup>8)</sup>) bedeutet dies, daß die Verfahrenskosten der zur Aufbringung der Kosten des ärztlichen Eingriffs endgültig verpflichtete Fürsorgeverband zu tragen hat. Die Einbeziehung des ärztlichen Eingriffs selbst in die Regelung für die gegen Krankheit versicherten Personen (Satz 1 des Abs. 1) empfiehlt sich zur Behebung aufgetretener Zweifel.

[...]

## Zum II. Abschnitt

Aus den Darlegungen des allgemeinen Teils der Begründung erhellt die Notwendigkeit, das Herstellen, Ankündigen und Inverkehrbringen von Mitteln zur Verhütung oder Unterbrechung der Schwangerschaft einer scharfen Regelung zu unterwerfen. Einzubeziehen sind auch die Mittel zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten, da vielfach dieselben Mittel sowohl zum Schutze vor geschlechtlicher Erkrankung als auch zur Verhütung oder Unterbrechung der Schwangerschaft dienen.

Zu § 11: Die Vorschrift des § 11<sup>9)</sup>) bezieht sich in Nr. 1 und 2 auf Mittel, die zur Unterbrechung der Schwangerschaft, in Nr. 4 auf solche, die zur Verhütung der Schwangerschaft dienen; die in Nr. 3 erwähnten Gegenstände werden zwar in der geschäftlichen Ankündigung und Anpreisung vielfach lediglich als Mittel zur Verhütung der Schwangerschaft bezeichnet, sie kommen aber nach ihrer Beschaffenheit in erster Linie als Mittel zur Unterbrechung der Schwangerschaft in Betracht.

Es ist erwiesen, daß vor allem der gewerbsmäßige Abtreiber sich dieser Mittel bedient. Der gewissenhafte Arzt bedarf ihrer nicht für seine aus gesundheitlichen Gründen gebotenen und daher erlaubten Maßnahmen und Eingriffe. Es kommt hinzu, daß die Anwendung der Mittel, zumal durch eine ungeübte Hand, leicht zu ernststen Gesundheitsschädigungen bei den betroffenen weiblichen

<sup>7)</sup> § 7 Abs. 1: „Die Kosten der Unterbrechung der Schwangerschaft oder der Unfruchtbarmachung sowie die Kosten des Gutachterverfahrens trägt für die bei einer reichsgesetzlichen Krankenkasse [...] versicherten Personen und deren anspruchsberechtigte Familienangehörigen die Krankenkasse.“

<sup>8)</sup> Vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 183.

<sup>9)</sup> Nach § 11 sollten Herstellung, Verkauf, Einfuhr und sonstige Inverkehrbringung u. a. folgender Mittel und Gegenstände verboten sein: (Nr. 1:) Pasten, Salben zur Einführung in die Gebärmutter; (Nr. 2:) sogen. „Mutterrohre (für sich allein oder in Verbindung mit Spritzen, Irrigatoren usw.)“; (Nr. 3:) „Intrauterinpressare jeder Art, Sterilets und ähnliche Gegenstände“; (Nr. 4:) „Tabletten, Salben und alle sonstigen Zubereitungen ähnlicher Art sowie Schwämmchen, Seidenpressare [...], sofern diese Mittel und Gegenstände dazu dienen, zur Verhütung der Schwangerschaft in die Scheide eingeführt zu werden.“

Personen führt. Dies gilt namentlich für die in Nr. 3 erwähnten Gegenstände, die in den letzten Jahren besonders stark verbreitet worden sind und viel Schaden angerichtet haben.  
[...]

## **Zitierhinweis**

Nr. 353 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes gegen Mißstände im Gesundheitswesen. [28. Mai 1934] ) in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d353>